INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

Protocolo Institucional

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDAS

2026

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

1. INTRODUÇÃO

Quedas em pacientes hospitalizados é um evento indesejável que pode causar desconforto ao paciente, e em casos que ocorra algum tipo de lesão, pode aumentar o tempo de internação e o custo de tratamento, pode ainda gerar ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões na credibilidade da instituição, além de repercussões de ordem legal. Pode ser um evento freqüente e limitante, considerado um marcador de fragilidade e declínio na saúde ou até preditor de morte.

Diversos fatores de risco e múltiplas causas interagem como agentes determinantes e predisponentes, tanto para quedas acidentais quanto para quedas recorrentes; impondo aos profissionais de saúde, o grande desafio de identificar e agir sobre os fatores de risco modificáveis e tratar os fatores etiológicos e comorbidades presentes.

A criação de um protocolo para prevenção de quedas e a avaliação de suas causas é uma oportunidade de aprendizagem para a equipe assistencial, por meio da análise de informações, feedback dos resultados para os profissionais e adoção de práticas de melhoria se necessário.

2. OBJETIVO

Reduzir a ocorrência de queda dos pacientes nos pontos de assistência e o dano delas decorrente, por meio da implantação/implementação de medidas que contemplem a avaliação de risco individualizada, a garantia ao cuidado multiprofissional e ao ambiente seguro, promoção da educação do paciente, familiares e profissionais.

3. CONCEITOS

Queda: Deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano. (Programa Nacional de Segurança do Paciente e Organização Mundial de Saúde).

SÃO CONSIDERADAS COMO QUEDAS:

. Quando encontramos o paciente no chão;

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

. Quando o paciente á amparado durante a queda (mesmo que não chegue ao chão);

. Quando o paciente escorrega de uma cadeira/poltrona/vaso sanitário para o chão.

As ocorrências de quedas podem ser da própria altura, de macas, de camas/berços ou de assentos, tais como: cadeira de rodas, poltronas, cadeiras, cadeiras higiênicas, banheiras, trocador de fraldas, vasos sanitários e outros.

Dano: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito deletério dele oriundo, incluindo-se doenças, dano ou lesão, sofrimento, incapacidade ou disfunção e morte.

4. AVALIAÇÃO DE RISCO PARA QUEDAS

A avaliação do risco de quedas deve ser feita no momento da admissão do paciente e ser repetida diariamente até a alta do paciente.

O grau do risco de queda será conforme a presença de fatores predisponentes identificados, tais como:

. Criança ≤ a 5 anos;

. Idoso ≤ a 65 anos sem acompanhantes;

. Uso de Medicação que altera o SNC (sedação, opióides e outros);

. Uso de Diuréticos e Laxantes (causadores de urgências urinárias e intestinais);

. Distúrbios Neurológicos (crise convulsiva, delírio, demência, paresia, parestesia e plegia);

. Dificuldade de Marcha; Déficit sensitivo (visão, audição e tato);

. Alteração do Nível de Consciência e Indicador de Repouso no Leito por Resultados Laboratoriais.

5. FATORES PREDISPONENTES PARA QUEDA

. Demográfico: Crianças menores de cinco anos; idosos maiores de sessenta e cinco anos.

. Psico-cognitivas: Declínio cognitivo, depressão, ansiedade.

. Condições de Saúde: Acidente Vascular Cerebral (AVC) prévio; hipotensão postural; tonteira; baixo índice de massa corpórea; anemias; insônia; incontinência ou urgência miccional; artrite; osteoporose; alterações metabólicas.

. Funcionalidade: Dificuldade no desenvolvimento das atividades diárias; necessidade de dispositivo de auxílio à marcha; fraqueza muscular; problemas articulares; deformidades nos membros inferiores.

. Comprometimento Sensorial: visão, audição e tato.

. Equilíbrio Corporal: marcha alterada.

. Uso de medicamentos: benzodiazepínicos, antiarrítmicos, anti-histamínicos, antipsicóticos, antidepressivos, digoxina, diuréticos, laxativos, laxantes musculares, vasodilatadores, hipoglicemiantes orais, insulina, polifarmácia (uso de 4 ou mais medicações).

. Obesidade mórbida.

. História prévia de quedas.

5.1 Pacientes com alto risco de queda:

. Paciente independente, que se locomove e realiza suas atividades sem ajuda de terceiros, mas possui pelo menos um fator de risco.

. Paciente dependente de ajuda de terceiros para realizar suas atividades, com ou sem a presença de algum fator de risco. Anda com auxílio (de pessoa ou de dispositivo) ou se locomove em cadeira de rodas.

. Paciente acomodado em maca, por exemplo, aguardando a realização de exames ou transferência, com ou sem a presença de fatores risco.

5.2 Pacientes com baixo risco de queda

. Paciente acamado, restrito ao leito, completamente dependente da ajuda de terceiros, com ou sem fatores de risco.
. Indivíduo independente e sem nenhum fator de risco.

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

6. AÇÕES PREVENTIVAS

6.1 Medidas Gerais

A unidade de saúde, orientada pelo seu Núcleo de Segurança do Paciente, deverá adotar medidas gerais para a prevenção de quedas de todos os pacientes, independente do risco. Tais medidas incluem:

. A criação de um ambiente de cuidado seguro conforme legislação vigente: pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação adequada, corredores livres de obstáculos (por exemplo, equipamentos, materiais e entulhos);

. O uso de vestuário e calçados adequados;

. Movimentação segura dos pacientes;

. Pacientes e familiares devem receber orientações quanto às medidas de prevenção de quedas adotadas pela instituição e à importância de sua participação ativa nesse processo. Devem ser incentivados a solicitar auxílio da equipe antes de levantar-se da cama ou da poltrona, especialmente após cirurgias, uso de medicamentos que possam causar sonolência ou tontura, ou quando houver limitações físicas. Também devem ser orientados a manter o ambiente organizado, utilizar calçados fechados e antiderrapantes, manter objetos de uso frequente ao alcance das mãos e informar imediatamente à equipe assistencial episódios de tontura, fraqueza, alterações do equilíbrio ou histórico prévio de quedas. A educação do paciente e da família contribui para a redução de eventos adversos e fortalece a cultura de segurança no ambiente hospitalar.

Essas ações devem ocorrer na admissão e durante a permanência do paciente no hospital. A elaboração e a distribuição de material educativo devem ser estimuladas.

6.2 Medidas Específicas:

. A unidade de saúde, orientada pelo Núcleo de Segurança do Paciente, devem definir o (s) profissional (ais) responsável (eis) por avaliar o risco de queda e definir as ações de caráter preventivo para pacientes que apresentem tal risco.

. Medidas individualizadas para prevenção de queda para cada paciente devem ser prescritas e implementadas.

. Políticas e procedimentos devem ser estabelecidos e implementados pela unidade para assegurar a comunicação efetiva entre profissionais e serviços sobre o risco de queda e risco de dano da queda nas passagens de plantão, bem como sobre as medidas de prevenção.

. A reavaliação do risco dos pacientes deve acontecer em caso de transferência de setor, mudança do quadro clínico, episódio de queda durante a internação ou na identificação de outro fator de risco.

A ocorrência de queda deve ser notificada e o paciente avaliado e atendido imediatamente para mitigação/atenuação dos possíveis danos.

7. NOTIFICAÇÃO E AÇÕES NA OCORRÊNCIA DE QUEDAS

No caso de ocorrer queda, colocar paciente no leito, comunicar a enfermeira de plantão para avaliação e exame físico. Solicitar avaliação médica. Registrar no prontuário as informações de ocorrência de queda. Notificar em PLANEJAMENTO E GESTÃO doc, que encontra-se em FOMULÁRIOS INTERNOS, no PORTAL do Hospital e informar a Gerencia de Risco em impresso próprio.

8. CAMPO DE APLICAÇÃO

Áreas de internação, centro obstétrico, bloco cirúrgico e serviço de atendimento ambulatorial (SAA)

9. INDICADORES:

. Proporção de pacientes com avaliação de risco de queda realizada na admissão.

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

. Número de quedas com dano.

. Número de quedas sem dano.

. Índice de quedas [(nº de eventos / nº de paciente-dia) *1000]: este indicador pode ser monitorado utilizando um diagrama de controle, visando não só construir a série histórica do evento, como também auxiliar a estabelecer metas e parâmetros de avaliação.

10. SEQUÊNCIA OPERACIONAL DA ROTINA

1º Enfermeiro:

- Identificar situações de risco de queda para pacientes internados, observação e externos, seguindo os fatores predisponentes;
- Assinalar na identificação do leito e no prontuário nos pacientes internados com riscos de quedas;
- Acomodar o paciente que circula pelo hospital em lugar segura, de forma a prevenir riscos de queda.
- Anotar em prontuário e/ou ficha de atendimento os fatores predisponentes para os riscos de queda;
- Supervisionar atitudes e possíveis riscos de quedas;
- Realizar na admissão do paciente a Escala de Morse informatizada no sistema MV e registrar na evolução.

2º Auxiliar e/ou Técnico de enfermagem:

- Identificar situações de risco de queda para pacientes internados, observação e externos, seguindo os fatores predisponentes;
- Conferir no prontuário e na identificação do leito dos pacientes internados com riscos de quedas;

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

• Acomodar o paciente que circula pelo hospital em lugar seguro, de forma a prevenir riscos de queda;

• Acompanhar o paciente na realização de exames, de maneira segura conforme grau de dependência, de forma a prevenir riscos de queda;

• Anotar em prontuário e/ou ficha de atendimento os fatores predisponentes para os riscos de queda;

• Comunicar possíveis riscos de quedas.

3º Equipe multiprofissional:

• Identificar situações de risco de queda para pacientes internados, observação e externos, seguindo os fatores predisponentes;

• Conferir no prontuário e na identificação do leito dos pacientes internados com riscos de quedas;

• Acomodar o paciente que circula pelo hospital em lugar segura, de forma a prevenir riscos de queda.

• Anotar em prontuário e/ou ficha de atendimento os fatores predisponentes para os riscos de queda;

• Comunicar possíveis riscos de quedas.

4º Equipe de Apoio:

• Manter o ambiente livre de riscos de quedas;

• Implementar medidas indispensáveis para prevenir quedas.

11. ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO E INDICADORES

• Manter um sistema de notificação de quedas e avaliação de suas causas;

• Notificar as quedas e suas causas ao Núcleo de Segurança do Paciente através do QR code ou SIGQUALI;

• Manter a atualização dos indicadores de queda no Hospital;

• Criar uma equipe de estudos acerca dos Procedimentos Operacionais Padrão para prevenção de Quedas de pacientes internados, observação e externos no Hospital.

Indicador de Taxa de Quedas

Definição:

Indicador utilizado para monitorar a ocorrência de quedas de pacientes durante a assistência à saúde, permitindo avaliar a efetividade das medidas preventivas adotadas pela instituição e subsidiar ações de melhoria contínua.

Fórmula:

$$\text{Taxa de quedas} = \frac{\text{Número de quedas ocorridas no período}}{\text{Número de pacientes-dia no período}} \times 1.000$$

$$\text{Taxa de quedas} = \frac{\text{Número de quedas}}{\text{Pacientes-dia}} \times 1000$$

Componentes do indicador:

- **Numerador:** número total de quedas ocorridas no período avaliado, com ou sem dano ao paciente.
- **Denominador:** número total de pacientes-dia no mesmo período.
- **Fator multiplicador:** 1.000 pacientes-dia.

Interpretação:

O resultado expressa o número de quedas para cada **1.000 pacientes-dia**. Taxas mais elevadas podem indicar a necessidade de revisão das estratégias de prevenção, capacitação da equipe e análise dos fatores contribuintes para a ocorrência dos eventos.

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

TABELA DE PREVENÇÃO DE QUEDA

<table>
<tr><td colspan="2">ADMISSÃO DO PACIENTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">ORIENTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANTO AO RISCO DE QUEDA E FORNECER FOLDERS E O TERMO DE CIÊNCIA E ESCLARECIMENTO SOBRE O RISCO DE QUEDA</td></tr>
<tr><td colspan="2">AVALIAÇÃO DE RISCO PARA QUEDA

UTILIZAÇÃO DA ESCALA DE MORSE</td></tr>
<tr><td>RISCO LEVE</td><td>RISCO MODERADO/ALTO</td></tr>
<tr><td>IMPLANTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DO ENFERMEIRO</td><td>INSERIR NO PROTOCOLO E IDENTIFICAR O PACIENTE/LEITO/PRONTUÁRIO QUANTO AO RISCO DE QUEDA</td></tr>
<tr><td colspan="2">REAVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDA

• DIÁRIO
• QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO DO ESTADO CLÍNICO</td></tr>
</table>

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

TABELA COM AS AÇÕES PREVENTIVAS PARA QUEDA

ADMISSÃO DO PACIENTE NA UNIDADE

AVALIAÇÃO DE RISCO PARA QUEDA

UTILIZAÇÃO DA ESCALA DE MORSE

RISCO LEVE	RISCO MODERADO	RISCO ALTO
AÇÕES PREVENTIVAS	**AÇÕES PREVENTIVAS**	**AÇÕES PREVENTIVAS**
IMPLANTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DO ENFERMEIRO	• ENTREGA DE FOLDER COM ORIENTAÇÕES AO RISCO DE QUEDA • IDENTIFICAR O PRONTUÁRIO, O LEITO E AS SOLICITAÇÕES DE PEDIDOS DE EXAMES COMPLEMENTARES COM SINALIZAÇÃO DE RISCO DE QUEDA • MANTER GRADES DA CAMA ELEVADAS E RODAS TRAVADAS • SOLICITAR ACOMPANHANTE • ASSEGURAR AMBIENTE ILUMINADO • VERIFICAR A UTILIZAÇÃO DE CALÇADOS APROPRIADOS • ORIENTAR A FAMÍLIA A COMUNICAR A ENFERMAGEM SEMPRE QUE O PACIENTE FICAR SEM ACOMPANHANTE • UTILIZAR CADEIRAS DE RODAS PARA TRANSPORTE • REALIZAR REFORÇO DIÁRIO DAS ORIENTAÇÕES	• ENTREGA DE FOLDER COM ORIENTAÇÕES AO RISCO DE QUEDA • IDENTIFICAR O PRONTUÁRIO, O LEITO E AS SOLICITAÇÕES DE PEDIDOS DE EXAMES COMPLEMENTARES COM SINALIZAÇÃO DE RISCO DE QUEDA • MANTER GRADES DA CAMA ELEVADAS E RODAS TRAVADAS • SOLICITAR ACOMPANHANTE • ASSEGURAR AMBIENTE ILUMINADO • VERIFICAR A UTILIZAÇÃO DE CALÇADOS APROPRIADOS • ORIENTAR A FAMÍLIA A COMUNICAR A ENFERMAGEM SEMPRE QUE O PACIENTE FICAR SEM ACOMPANHANTE UTILIZAR CADEIRAS DE RODAS PARA TRANSPORTE • UTILIZAR FAIXAS PRÓPRIAS PARA CONTENÇÃO FÍSICA NO LEITO, SE ESTA FOR NECESSÁRIA • COMUNICAR AOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM A NECESSIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE AO BANHEIRO OU ADEQUAR HORÁRIOS DE CUIDADOS DO PACIENTE

HOUVE QUEDA

SIM → IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE E NOTIFICAR NO IMPRESSO ONLINE OU ESCRITO

NÃO → MANTER AS CONDUTAS DE ACORDO COM O RISCO DO PACIENTE

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

ANEXO I

INFORMAÇÕES A SEREM REGISTRADAS NAS OCORRÊNCIAS DE QUEDA PELO ENFERMEIRO IMEDIATO

- Risco de queda identificado na admissão;
- Período do dia em que ocorreu o evento;
- Local da queda;
- Como ocorreu a queda;
- Se o paciente estava sozinho ou com acompanhante;
- Fatores de risco predisponentes;
- Presença de morbidade;
- Medicações em uso;
- Registro da avaliação/ conduta médica após a queda;
- Perfil dos pacientes que apresentam quedas;
- Consequências da queda;
- Causas das quedas;
- Prorrogação do tempo de permanência do paciente, devido à queda.

FINALIDADE: A criação de um instrumento de notificação de quedas, avaliação de suas causas e geração de informações para produção de indicadores para monitorar o desempenho é uma oportunidade de aprendizagem para a organização, por meio de análise das notificações.

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

ANEXO II

ESCALA DE QUEDAS DE MORSE (sistema MV)

Nome:_____Idade:_____Sexo: F ( ) M ( ) Enf:___ Leito:_____

Nº	CATEGORIA	ESCORE
1	Histórico de queda recente NÃO SIM	0 25
2	Diagnóstico secundário NÃO SIM	0 15
3	Auxílio para deambular Nenhum/ Acamado/ Auxiliado por profissional da Saúde Muleta/Bengala/ Andador Mobiliário/parede	0 15 30
4	Terapia endovenosa/Dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado NÃO SIM	0 20
5	Marcha Normal/Sem deambulação, acamado, Cadeira de Rodas Fraca Comprometida, cambaleante	0 10 20
6	Estado Mental Orientado, capaz quanto a sua capacidade/limitação Superestima capacidade/esquece limitações	0 15
	TOTAL	

ESCORE	RISCO
<41	RISCO MÉDIO
41-51	RISCO ELEVADO
>51	RISCO MUITO ELEVADO

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

12. REFERÊNCIAS

Diretrizes Clínicas, Protocolos Clínicas – PREVENÇÃO DE QUEDAS. Disponível em www.fheming.mg.gov.br e intranet. Acesso em: 13 de dezembro de 2018.

MINISTERIO DA SAÚDE. Anexo 01: PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS. Ministério da Saúde/ Anvisa/ Fiocruz;2013. Disponível em: http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle infeccoes/pasta12/protocolos_cp_n6_2013_prevencao.pdf. Acesso em: 13 de dezembro de 2018.

PROTOCOLO DE ENFERMAGEM – PREVENÇÃO DE QUEDAS. Disponível em: http://www.hemorio.rj.gov.br/Html/pdf/Protocolo_enfermagem_prevencao_quedas.pdf. Acesso em: 13 de dezembro de 2018.

Organização Mundial de Saúde.OMS(World Health Organization.Conceptual Framework for the International classification of Patient Safety.Final Techenical Report 2009.

FONSECA, Ariadne S. et al. Segurança do paciente. São Paulo: Martinari, 2014.

Hemorio. Protocolos de Enfermagem: identificação de risco de prevenção de quedas. 1ª Ed. Rio de Janeiro, 2010.

Elaborado por:	Atualizado e revisado por:	Reconhecido por:
Ingrid Anny Pessoa de Andrade Sobreira CCIH/ Núcleo de Segurança do Paciente	Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra Núcleo de segurança do paciente	Giulianna Carla Marçal Lourenço Coordenadoras de Enfermagem Sônia da Silva Delgado Diretora Assistencial
	Data: 01/06/2026	Data: 01/06/2026